



Résumé : 35 recommandations organisées en 3 périodes (pré-, per- et postopératoire) pour un programme de réhabilitation rapide après chirurgie colorectale programmée. Facteurs non suffisamment appliqués en pratique mais recommandés : apport de carbohydrates préopératoire, optimisation hémodynamique peropératoire, reprise de l'alimentation orale avant h24, mastication de gommes postopératoire, lever et marche avant h24. Pratiques confirmées inutiles : préparation colique mécanique (chirurgie colique), sonde nasogastrique systématique, drainage chirurgical systématique (chirurgie colique).

Méthodologie — GRADE + vote Delphi (double cotation)

Méthode GRADE : qualité des preuves en 4 catégories (Haute/Modérée/Basse/Très basse) ; force toujours binaire — **forte** (GRADE 1+/1-, « il faut faire / ne pas faire ») ou **faible** (GRADE 2+/2-, « il est possible de faire / ne pas faire »). **Particularité de cette RFE :** chaque recommandation porte en plus un résultat de **vote Delphi** indépendant du groupe de relecture (30 experts, 3 tours) — **Accord Fort** ou **Accord Faible** — deux axes distincts (force de la preuve vs. force du consensus), transcrits séparément ici, jamais fusionnés. Sur 35 recommandations : 22 fortes (Grade 1), 8 faibles (Grade 2), 5 sans grade GRADE (preuves insuffisantes, chip AP) ; 28 Accord Fort, 7 Accord Faible.

1+	1-	2+	2-	AP
----	----	----	----	----

GRADE — 1+/1- : recommandation **forte** (« il faut faire / ne pas faire ») ; 2+/2- : recommandation **faible** (« il est possible de faire / ne pas faire ») ; **AP** : méthode GRADE non applicable (absence de preuves suffisantes). Chaque recommandation porte en outre un résultat de vote Delphi indépendant, **Accord Fort** ou **Accord Faible**, indiqué dans le texte de chaque ligne.

Période préopératoire (R1-10)

Réf.	Recommandation	Grade
R1	L'information et les conseils liés au programme de réhabilitation sont des obligations réglementaires (loi n°2009-879 du 21 juillet 2009). — Accord Fort	AP
R2	Lors d'une chirurgie colique, une préparation colique n'est pas recommandée de manière systématique. — Accord Fort	1-
R3	Pour une chirurgie rectale, les données ne permettent pas d'émettre de recommandation sur l'utilité de la préparation colique. — Accord Faible	AP
R4	Les données ne permettent pas d'émettre de recommandation sur l'impact d'une prémédication anxiolytique. — Accord Fort	AP
R5	Les recommandations des sociétés savantes sont valides : jeûne de 2 h pour les liquides clairs, 4 à 6 h pour les solides. — Accord Fort	AP
R6	Il est recommandé de donner une solution isotonique riche en carbohydrates aux patients ASA 1 ou 2 en préopératoire. — Accord Fort	1+
R7	Il n'est pas recommandé de donner cette solution aux patients diabétiques ou ayant des troubles de la vidange gastrique. — Accord Fort	1-
R8	Il est probablement recommandé de prescrire une immunonutrition en préopératoire d'une chirurgie colorectale carcinologique. — Accord Fort	2+
R9	Il n'est pas recommandé de poursuivre une immunonutrition en postopératoire d'une chirurgie carcinologique. — Accord Fort	1-
R10	Il n'est pas recommandé de prescrire une immunonutrition préopératoire pour une chirurgie colorectale non carcinologique. — Accord Faible	1-

Période peropératoire (R11-18)

Réf.	Recommandation	Grade
R11	Un apport excessif de solutés n'est pas recommandé pendant le geste chirurgical. — Accord Fort	1-



Réf.	Recommandation	Grade
R12	L'optimisation des apports liquidiens peropératoires, basée sur la mesure d'un paramètre hémodynamique reflétant la volémie, est recommandée. — Accord Fort	1+
R13	L'administration d'une dose unique de corticostéroïdes en préopératoire immédiat est probablement recommandée. — Accord Faible	2+
R14	La prévention de l'hypothermie peropératoire est recommandée. — Accord Fort	1+
R15	L'administration d'une antibioprophylaxie couvrant les germes aérobies et anaérobies est recommandée. — Accord Fort	1+
R16	La prévention des nausées et vomissements postopératoires est recommandée (stratégie basée sur le score d'Apfel). — Accord Fort	1+
R17	La chirurgie par laparoscopie est recommandée. — Accord Fort	1+
R18	En cas de laparotomie, aucune recommandation ne peut être faite sur le type d'incision (transversale ou verticale). — Accord Fort	AP

Période postopératoire — analgésie (R19-26)

Réf.	Recommandation	Grade
R19	Il n'est pas recommandé de laisser une sonde nasogastrique après une chirurgie colorectale. — Accord Fort	1-
R20	Il est recommandé de prescrire une analgésie multimodale privilégiant les antalgiques non morphiniques et/ou une technique d'ALR. — Accord Fort	1+
R21	Les AINS sont probablement recommandés, mais un doute persiste sur le risque de fistule digestive. — Accord Faible	2+
R22	Après chirurgie par laparoscopie, l'analgésie péridurale thoracique n'est probablement pas recommandée. — Accord Faible	2-
R23	Après chirurgie colorectale par laparotomie, l'analgésie péridurale thoracique est une des techniques recommandées. — Accord Fort	1+
R24	L'administration intraveineuse continue de lidocaïne est recommandée (alternative en cas de laparoscopie/contre-indication à la péridurale). — Accord Fort	1+
R25	L'irrigation pariétale avec une perfusion d'anesthésique local est probablement recommandée. — Accord Faible	2+
R26	Le bloc dans le plan du muscle transverse de l'abdomen (TAP block) est probablement recommandé, mais son bénéfice sur la réhabilitation reste à démontrer. — Accord Fort	2+

Période postopératoire — suite (R27-35)

Réf.	Recommandation	Grade
R27	L'administration d'une héparine de bas poids moléculaire à dose prophylactique élevée est recommandée. — Accord Fort	1+
R28	Lors de la chirurgie colique, la mise en place d'un drainage n'est pas recommandée. — Accord Fort	1-
R29	Lors d'une chirurgie avec anastomose sous-péritonéale, un drainage aspiratif est probablement recommandé. — Accord Fort	2+
R30	Le lever précoce (avant h24) est recommandé. — Accord Fort	1+
R31	Il est recommandé de débiter précocement (avant h24) une alimentation orale. — Accord Fort	1+



Réf.	Recommandation	Grade
R32	Après une chirurgie colique, la durée du sondage vésical ne doit pas excéder 24 heures. — Accord Fort	1+
R33	Lors d'une chirurgie du bas rectum nécessitant un drainage vésical > 4 jours, un cathéter sus-pubien est recommandé chez l'homme. — Accord Fort	1+
R34	L'administration de naloxone n'est pas recommandée. — Accord Faible	1-
R35	La mastication de gommes (chewing-gum) est probablement recommandée. — Accord Fort	2+

Annexe — classement par période et impact (source, reproduit)

Paramètre	Recommandation(s)
Information et conseils au patient	Oui (recommandation principale).
Préparation colique	Non si chirurgie colique. Absence de recommandation si chirurgie rectale.
Prémédication anxiolytique	Absence de données.
Jeûne préopératoire	Solides : 6 heures. Liquides clairs et/ou sucrés : 2 heures.
Apport en carbohydrates (veille + matin)	Oui si ASA 1 ou 2. Non si diabète ou troubles de la vidange gastrique.
Immunonutrition	Oui en préopératoire de chirurgie carcinologique (recommandation principale). Non en préopératoire de chirurgie non carcinologique, non en postopératoire (recommandations secondaires).
Apports liquidiens peropératoires	Oui : optimisation de la volémie (principale). Non : apport excessif de solutés (secondaire).
Prévention du stress opératoire	Oui : dose unique de corticostéroïdes en préopératoire immédiat (secondaire).
Prévention des infections du site opératoire	Oui, par la prévention de l'hypothermie peropératoire (principale) et l'antibioprophylaxie (secondaire).
Prévention des NVPO	Oui, systématique (recommandation principale).
Voie d'abord chirurgical	Par laparoscopie (principale). Si laparotomie : aucune recommandation sur le type d'incision.
Sondes nasogastriques	Non, à enlever systématiquement en fin d'intervention (recommandation principale).
Analgesie postopératoire — principes généraux	Analgesie multimodale privilégiant les antalgiques non morphiniques et/ou l'ALR (principale). Prescription d'AINS (secondaire).
Analgesie postopératoire — laparotomie	Oui : analgesie péridurale thoracique (principale). Secondaires : irrigation pariétale, ou lidocaïne IV, ou TAP block.
Analgesie postopératoire — laparoscopie	Oui : lidocaïne IV continue (principale). Non : analgesie péridurale thoracique. Secondaires : irrigation pariétale, ou TAP block.
Thromboprophylaxie	Oui, par une HBPM à dose prophylactique élevée (recommandation principale).
Mise en place d'un drainage chirurgical	Oui si anastomose sous-péritonéale (secondaire). Non si chirurgie colique (principale).
Mobilisation précoce	Oui, avant h24 (recommandation principale).
Alimentation orale	Oui, à débiter avant h24 (recommandation principale).



Paramètre	Recommandation(s)
Sondage vésical	Oui, < 24 h après chirurgie colique (principale). Chirurgie du bas rectum : cathéter sus-pubien chez l'homme (secondaire).
Prévention de l'iléus postopératoire	Oui : mastication de gommes (secondaire). Non : administration de naloxone (secondaire).

Sources et avertissement

SFAR/SFCD, « Réhabilitation rapide après une chirurgie colorectale programmée », RFE, Ann Fr Anesth Réanim 33 (2014) 370-384. Population : chirurgie colorectale programmée (carcinologique ou non), patient autonome en préopératoire, sans critère d'âge. ~40 000 interventions/an en France (80 % programmées, 70 % carcinologiques) ; durée de séjour moyenne 18 jours, mortalité 3,4 %, complications 25-35 % — un référentiel de réhabilitation appliqué avec une bonne compliance réduit ces deux derniers indicateurs.

Avertissement — document de 2014 : cette fiche est une synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des 35 recommandations et le tableau de synthèse en annexe, mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la SFAR/SFCD. Les pratiques de réhabilitation rapide (notamment les techniques d'analgésie et les seuils d'apport liquidien) ayant pu évoluer depuis 2014, se référer à un avis spécialisé et aux recommandations actualisées avant toute décision thérapeutique.